

Le Lupus érythémateux systémique (LES)



I. Introduction :

Le lupus érythémateux systémique (LES) est une maladie auto-immune systémique. Il est caractérisé par la production d'auto-anticorps dirigés contre des constituants nucléaires et cytoplasmiques.

Entraîne des dépôts de complexes immuns responsables d'une inflammation chronique multi-organique.

- **Prévalence:** 20-150/100 000 habitants.
- **Sexe:** 9 femmes pour 1 homme.
- **Âge de début:** entre 15 et 45 ans.
- **Étiologie multifactorielle:** facteurs génétiques, hormonaux, environnementaux et épigénétiques.

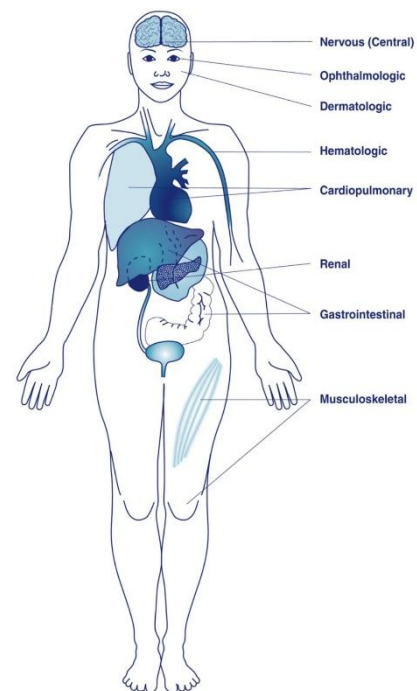
II. Physiopathologie :

Le LES résulte d'une perte de tolérance Immunitaire conduisant à :

- Une activation anormale des lymphocytes B et T
- à une production excessive d'interférons de type I
- à la formation de complexes immuns pathogènes.

Mécanismes principaux :

1. Défaut d'élimination des cellules apoptotiques.
2. Activation des lymphocytes B autoréactifs.
3. Production d'auto-anticorps (anti-ADN natif, anti-Sm, anti-RNP)
4. Activation du complément (C3, C4)
5. Infiltration inflammatoire tissulaire.



III. Manifestations cliniques :

Le LES est **polymorphe**, atteignant presque tous les organes.

Atteinte	Manifestations typiques
Cutanée	Erythème malaire en aile de papillon, photosensibilité, lésions discoïdes
Articulaire	Arthralgies, arthrites non érosives (mains, poignets, genoux)
Rénale	Protéinurie, hématurie, syndrome néphrotique (néphrite lupique)
Hématologique	Anémie hémolytique auto-immune, leucopénie, thrombopénie
Neurologique	Convulsions, psychose lupique, neuropathies
Cardio-pulmonaire	Péricardite, pleurésie, HTAP secondaire
Digestive	Hépatomégale, pancréatite, vascularite intestinale

1. Atteinte cutanée :

a) Lupus cutané aigu :

- Topographie: pommettes, nez
- Aspect: érythémateux, maculeux maculo-papuleux, finement squameux
- Décolleté, membres, muqueuses accompagnent volontiers les poussées
- Disparaissent sans séquelles

b) Lupus cutané subaigu :

- Respect du visage
- Décolleté, membres
- Très photosensible
- Aspect annulaire ou polycyclique
- Lupus néonatal

c) Lupus cutané chronique :

15% des LES lésions discoïdes :

- Erythème télangiectasique squames épaisses, atrophie cicatricielle
- Visage, extrémités, voire l'ensemble du tégument

2. Atteinte rhumatologique :

- Souvent inaugurale
- Très fréquente
- Arthrites aiguës : le plus souvent oligoarthritis, polyarthrite bilatérale et symétrique
- Arthrite subaiguë, arthrite chronique (plus rare)
- Arthromyalgies
- Topographie :
MCP, IPP, carpes, genou, cheville,
Rachis épargné
- Déformations possibles : main de Jaccoud (hyperlaxité capsuloligamentaire)
- Radiographies : pas de destruction articulaire
- Ténosynovites des mains

3. Atteinte rénale :

- Anomalies biologiques urinaires : 40% survenue au cours des 1ères années du lupus
- Atteinte surtout glomérulaire
 - protéinurie,
 - hématurie,
 - altération fonction rénale
 - HTA
- Etude histologique en microscopie optique et immunofluorescence caractérisation de l'atteinte glomérulaire

4. Atteinte neurologique :

- 30 à 60% des cas grande variété de présentation,
- Pronostic,
- Mécanisme SNC essentiellement

a) AVC :

- Ischémiques le plus souvent fortement associés à la présence d'aPL -
 - Par effet direct
 - Par atteinte valvulaire cardiaque responsable d'embolies artérielles
- Risque de récides avec séquelles importantes en l'absence de traitement

b) Epilepsie :

- 15% des lupus de tout type
- Peut précéder les autres signes de plusieurs années (rare)
- Pronostic non péjoratif si isolées sur le plan neurologique
- Fréquemment associée à présence d'aPL

c) Autres :

- Atteinte des nerfs crâniens: noyau ou périphérique
- Atteinte médullaire: souvent grave
- Tableaux de pseudo-sclérose en plaque (par exemple association d'une névrite optique avec atteinte SNC)
- Chorée
- Neuropathies périphériques
- Méningite lymphocytaire aseptique spécifique
- Céphalées: relativement fréquente parfois migraineuse

5. Atteinte cardiaque :

- Péricardite fréquence: 30%, inaugurale très corticosensible
- Myocardite inflammatoire rare,
 - Insuffisance cardiaque
 - Troubles du rythme
 - Troubles de la conduction
- Atteinte valvulaire
- Présence d'aPL +++
 - Epaisissements valvulaires végétations possibles (endocardite de libman sachs)
 - Insuffisances > rétrécissements
 - Risque: greffe bactérienne ++ embolies artérielles

6. Manifestations vasculaires :

- Phénomène de Raynaud : 35% des cas
- HTA: atteinte rénale, forte corticothérapie
- Thromboses:
 - fortement liées aux aPL
 - fréquentes,

- spontanément récidivantes
- artérielles, veineuses, microvasculaires
- toutes les localisations sont possibles
- veineuses: siège volontiers atypique
- microthromboses: expression cutanée et rénale

7. Atteinte pulmonaire : rare

- Pleurésies 25% des lupus, exsudative, lymphocytaire, uni- ou bilatérale, très corticosensible
- Pneumonie lupique
- Fibrose interstitielle
- HTAP: peut compliquer des migrations emboliques ou être primitive
- Hémorragie intra-alvéolaire:
 - rare (< 4%) toux, dyspnée, hémoptysie;
 - opacités alvéolaires (parfois poumon blanc);
 - déglobulisation;
 - LBA: rosé, sidérophages;
- Lupus en poussée, atteinte rénale presque constante; 36% de mortalité

8. Manifestations diverses :

- Phénomène de Raynaud : 35% des cas
- Alopécie
- Photosensibilité
- Lors des poussées marquées :
 - Signes généraux : fièvre, asthénie, amaigrissement
- Parfois adénopathies périphériques, splénomégalie

9. Atteinte hématologique :

- Anémie inflammatoire
- Anémie hémolytique auto-immune à test de Coombs direct positif
- Leucopénie modérée (lymphopénie ou neutropénie)
- Thrombopénie périphérique immunologique (15 à 25%)

IV. Explorations diagnostiques :

1. Examens biologiques :

- VS et CRP : VS souvent élevée, CRP modérée.
- Hémogramme : anémie, leucopénie, thrombopénie.
- Protéinurie des 24 h, créatinine, clairance rénale.
- Complément (C3, C4, CH50) : abaissés en phase active.
- Auto-anticorps :
 - ANA (sensibilité > 95%)
 - Anti-dsDNA (spécificité élevée, corrélé à l'activité rénale)
 - Anti-Sm, Anti-RNP, Anti-SSA/SSB

2. Imagerie et histologie :

- Biopsie rénale indispensable en cas de néphrite lupique.
- IRM cérébrale en cas d'atteinte neurologique.

V. Traitement :

1) Principes:

- Contrôler l'activité de la maladie.
- Prévenir les poussées.
- Limiter la toxicité médicamenteuse.

2) Situation :

- Léger à modéré
- Modéré à sévère
- Réfractaire/sévère

3) Traitement recommandé :

- Hydroxychloroquine ± corticoïdes faibles doses
- Corticoïdes + immunosuppresseurs (Azathioprine, Mycophénolate mofétil, Cyclophosphamide)
- Biothérapies: Belimumab (anti-BLyS), rituximab (anti-CD20)

Prise en charge thérapeutique :

✓ **Traitements de fond :**

- Hydroxychloroquine: pierre angulaire du traitement (effet immunomodulateur, antithrombotique).
- Corticothérapie: poussées modérées à sévères.
- Immunosuppresseurs: Azathioprine, Mycophénolate mofétil, Cyclophosphamide selon l'organe atteint

✓ **Thérapies ciblées :**

- Belimumab (anti-BlyS): diminue l'activité des lymphocytes B.
- Anifrolumab: anticorps monoclonal anti-IFN α (nouvelle approche prometteuse).

✓ **Mesures associées :**

- Photoprotection stricte.
- Éviction des médicaments inducteurs de lupus.
- Prévention cardiovasculaire et ostéoporose.